TESAMORELIN

Análogo sintético de GHRH · 44 aminoácidos · Egrifta®

10 mg

Tesamorelin es un **análogo sintético de la GHRH (Hormona Liberadora de GH)** de 44 aminoácidos, aprobado por la FDA en 2010. Es el único péptido con ensayos clínicos Fase 3 que demuestran una reducción promedio del **15-20% de la grasa visceral abdominal** en 26 semanas. A diferencia de la HGH directa, estimula la hipófisis de forma fisiológica, manteniendo los mecanismos naturales de retroalimentación.

MECANISMO DE ACCIÓN

GHRH R→GH	**Estimulación Fisiológica de GH** Se une a los receptores GHRH en los somatotropos de la hipófisis anterior, activando la adenilil ciclasa y aumentando el AMPc. Esto estimula la producción y liberación de GH de forma **pulsátil y fisiológica**, respetando los mecanismos de retroalimentación del cuerpo.
VAT LIPÓLISIS	**Reducción Selectiva de Grasa Visceral** El aumento de GH activa la lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo visceral (VAT), promoviendo la lipólisis selectiva. Acto **sin afectar la grasa subcutánea** ni la masa muscular magra: reduce donde más importa.
IGF-1 METAB.	**Mejora Metabólica vía IGF-1** El aumento de GH eleva el IGF-1 hepático, que mejora la sensibilidad insulínica, reduce triglicéridos y mejora el perfil lipídico. También reduce la grasa hepática (NAFLD/MASH) hasta un **37%**.
DPP-4 ESTABLE	**Alta Estabilidad Enzimática** La modificación N-terminal con un grupo hexenoico lo protege de la degradación por la enzima DPP-4, aumentando su vida media y eficacia respecto al GHRH natural o a la sertmorelina.

BENEFICIOS CLÍNICOS INVESTIGADOS

TESAMORELIN

Análogo sintético de GHRH · 44 aminoácidos · Egrifta®

10 mg

Área	Beneficio investigado
Grasa visceral	Reducción promedio del **15.2%** de grasa visceral abdominal en 26 semanas (ensayos Fase 3). Efecto selectivo: no afecta la grasa subcutánea.
Hígado (NAFLD)	Reducción del **37%** de la grasa hepática en pacientes con NAFLD asociado a VIH (Stanley et al., NEJM). Investigado para MASH.
Perfil metabólico	Reduce triglicéridos y mejora el ratio colesterol total/HDL. Sin empeorar la tolerancia a la glucosa.
Composición corporal	Preserva o aumenta la masa muscular magra mientras reduce la grasa visceral. Mejora la densidad muscular sin efecto sobre la grasa subcutánea.
Cognición	Investigado para mejorar la función cognitiva, la memoria y la claridad mental en adultos mayores con deterioro cognitivo leve.
Energía y sueño	Mejora la calidad del sueño, la vitalidad y los niveles de energía a través de la optimización del eje GH/IGF-1.

Tesamorelin vs CJC-1295 + Ipamorelin vs HGH:
• **Tesamorelin**: acción selectiva sobre grasa visceral. El único con datos Fase 3 y aprobación FDA. Ideal para grasa abdominal y hígado graso.
• **CJC-1295 + Ipa**: efecto más amplio sobre GH. Mejor para composición corporal general y sueño.
• **HGH directa**: más potente pero mayor riesgo de efectos secundarios y supresión endógena.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

TESAMORELIN

Análogo sintético de GHRH · 44 aminoácidos · Egrifta®

10 mg

1	**Preparar materiales** Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.
2	**Limpiar con alcohol** Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.
3	**Cargar el agua** Con la jeringa, extrae **1 ml** de agua bacteriostática.
4	**Añadir al vial del péptido** Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.
5	**Disolver suavemente** Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar** para evitar degradar el péptido.
6	**Conservar correctamente** Guarda el vial reconstituido en el **refrigerador (2-8°C)**. No congelar una vez reconstituido. Usar en máx. **30 días**.

TESAMORELIN

Análogo sintético de GHRH · 44 aminoácidos · Egrifta®

10 mg

REFERENCIA DE DOSIFICACIÓN

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	1 ml por vial
Concentración resultante	10 mg/ml → 1 mg = 10 unidades
Dosis típica por inyección	2 mg por inyección (una vez al día · dosis estándar clínica)
Unidades en jeringa (100U)	20 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) · Zona abdominal o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C · Máx. **30 días**

■■ **Timing óptimo:** Inyectar por la noche en ayunas (30 min antes de comer o 2 horas después de cenar) para aprovechar el pico nocturno natural de GH. Rotar los sitios de inyección dentro del abdomen. Los resultados sobre la grasa visceral son visibles a partir de las 8-12 semanas. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8°C) máx. 45 días con agua bacteriostática.